

人员详细多方位的了解患者的性格、日常习惯和病情等信息,个性化布置病房;在患者入住后,保持患者病房安静温馨,适当有序的安排患者的日常活动,做一些简单的劳务,比如扫地、清洗自己的衣物以及洗漱穿衣,多安排一些娱乐活动,开阔患者的思想,增强患者与人沟通的能力,加强患者重新生活的信心,消除疾病带来的身体和心理上的双重折磨,并且定期与患者和家属沟通病情,交流护理内容^[6]。我院在恢复期精神分裂患者的常规基础护理之上加入人文关怀的护理方法,护理效果显著,患者的各项指标以及康复效果等都得到了改善,由此分析得,恢复期精神分裂症患者采用人文关怀的护理方法具有良好的效果,值得研究和推广应用。

综上所述,人文关怀的护理策略对精神分裂患者的恢复有显著效果,个性化的护理内容以及人性化的护理方法都使患者感受到温暖,对重新融入社会更有信心,积极配合医生治疗,

从而达到事半功倍的效果。值得探索研究和临床医学上推广应用。

【参考文献】

- [1] 赵美兰. 探讨人文关怀应用于恢复期精神分裂症患者护理中的临床效果[J]. 中国保健营养, 2016, 26(24): 268-269.
- [2] 陈静静, 程晴晴. 恢复期精神分裂症患者护理中人文关怀的应用分析[J]. 重庆医学, 2017, 15(A03): 313-314.
- [3] 安红端. 人文关怀护理对恢复期精神分裂症患者康复情况及社会功能的影响分析[J]. 医药前沿, 2016, 6(6): 304-305.
- [4] 陈华. 恢复期精神分裂症护理中运用人文关怀的效果观察[J]. 中国继续医学教育, 2018(1): 155-156.
- [5] 周育闽. 人文护理对恢复期精神分裂症患者的临床治疗影响[J]. 医药卫生: 文摘版, 2016, 13(4): 00206-00206.

缺血性脑血管病治疗中远程缺血预适应的效果影响研究

王国强

(山西省潞安集团总医院神经内科 山西长治 046204)

【摘要】目的: 研究远程缺血预适应对缺血性脑血管病(ICVD)的治疗效果。**方法:** 采用系统随机化法将我院2016年12月—2017年12月收治的68例缺血性脑血管病患者,分为对照组和观察组,每组分别34例,两组患者均采用常规药物进行治疗,观察组在常规药物进行治疗的基础上使用远程缺血预适应,分析两组患者治疗前后影像学检查结果、NIHSS评分和血压变化情况。**结果:** 观察组的NIHSS评分变化显著优于对照组($P < 0.05$);观察组的新发梗死发生率少于对照组($P < 0.05$);观察组的梗死体积缩小人数多于对照组($P < 0.05$);两组患者治疗前后血压变化不显著($P > 0.05$)。**结论:** 对缺血性脑血管病采用远程缺血预适应训练,不仅可以减少新发梗死发生率、促进梗死体积的缩小,也有利于神经功能的恢复,更有利于改善患者病情。

【关键词】 缺血性脑血管病; 远程缺血预适应; 治疗效果

【中图分类号】 R742

【文献标识码】 A

【文章编号】 1007-8231(2018)17-0189-02

随着全球人口老龄化的快速到来,缺血性脑血管病(Ischemic cerebrovascular disease, ICVD)对于老年人而言,已呈现出逐年增长的趋势,而目前在临床上尚没有明确的治疗方案,但是根据相关研究表明^[1],使用常规药物治疗可以改善患者病情,而为进一步完善并提高治疗效果,我院在常规药物治疗的基础上采用远程缺血预适应,希望可以更好、更有效的预防和治疗这类疾病。现具体报告如下。

1. 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2016年12月—2017年12月收治的68例缺血性脑血管病(ICVD)患者,经过医院诊断后,确定具有缺血性脑血管病的临床特征,经过医院的治疗后,可以将危险因素控制在正常范围内,其中男38例,女30例,年龄45~75岁,平均(60.04.4)岁。然后采用系统随机化法将患者分为对照组和观察组,每组各34例,其中对照组男18例,女16例,年龄45~73岁,平均(59.04.2)岁;观察组男20例,女14例,年龄47~75岁,平均(61.04.6)岁,其中两组患者基本资料无显著性差异($P > 0.05$),不具有统计学意义。

1.2 治疗方法

两组患者在入院后均用常规药物进行治疗,降血压、降血脂、改善凝血功能等药物,如硝苯地平、甲钴胺、拜阿司匹林等^[2],其中药物剂量要根据患者的身体状况和病情变化给予适当改变。而观察组在常规药物治疗的基础上使用远程缺血预适应的训练:使用远程缺血适应仪(TDFT-01)对双臂上端的气囊加压,时间持续2min,而后释放气囊,休息4min,如此作为一个循环,总共重复五次^[3]。同时两组患者在治疗期间均为同一组医护人员进行训练、检查、观察、治疗、记录病情等。

1.3 观察指标

观察并记录两组患者在治疗前后每月的影像学检查结果以及临床症状,其中包括NIHSS评分、血压、新发梗死、梗死体积情况,最后进行统计学数据分析。

1.4 统计学方法

研究采用SPSS18.0统计软件,对本次数据进行统计学分析,计量资料($\bar{x} \pm s$)作 t 检验;计数资料(%)行 χ^2 检验, $P < 0.05$,差异具有统计学意义。

2. 结果

2.1 两组患者治疗前后NIHSS评分、血压变化情况分析比较

由表1可知:两组患者的NIHSS评分在治疗前无显著性变化($P > 0.05$),在治疗后,观察组的NIHSS评分变化显著高于对照组($P < 0.05$);而两组患者治疗前后血压变化情况不显著($P > 0.05$)。

表1 两组患者治疗前后NIHSS评分、血压变化情况比较

组别(n)	NIHSS 评分		血压(mmHg)	
	治疗前	治疗后	治疗前	治疗后
对照组 (n=34)	17.58±2.53	16.67±5.75*	104~140/ 55~90	95~145/ 60~90
观察组 (n=34)	17.61±2.48	14.36±4.61**	103~140/ 55~90	100~145/ 55~95
t	1.85		12.63	
P	> 0.05		< 0.05	

注:与治疗前比,* $P < 0.05$;与对照组比,** $P < 0.05$

2.2 两组患者影像学检查结果分析比较

由表2可知:观察组的新发梗死发生率少于对照组($P <$

0.05); 观察组的梗死体积缩小人数显著高于对照组 ($P < 0.05$)。

表 2 两组患者影像学检查结果分析比较 (%)

组别 (n)	新发梗死		梗死体积	
	无 (%)	有 (%)	缩小者 (%)	其他 (%)
对照组 (n=34)	70.59 (24)	29.41 (10)	32.35 (11)	67.65 (23)
观察组 (n=34)	94.12 (32)	5.88 (2)	73.53 (25)	26.47 (9)
t		6.48		13.95
P		< 0.05		< 0.05

3. 讨论

缺血性脑血管病是由于脑血管缺血导致供血区出现局灶性脑功能障碍, 该障碍持续时间从数分钟到几个小时, 最后可能会发展为卒中中的一类疾病^[4], 其常伴有突发短暂的偏侧运动或感觉障碍、短暂的失语 (优势半球缺血)、恶心、呕吐、复视、眩晕、交叉性运动和感觉障碍等症状^[5]。而此病亦常见于中老年群体。为此我院对缺血性脑血管病患者在给予常规药物治疗的基础上, 采用远程缺血预适应, 希望为更好、更有效的预防和治疗这类疾病。

该病由于缺血预适应的作用点在靶细胞, 所以对心脏和脑不适应, 而远程缺血预适应不仅提高一个器官的局部组织器官的重复缺血和缺氧的耐受力, 也可以避免适应过程中引起的缺

血风险, 同时可以恢复供血后心肌梗死面积明显减少^[7]。而相关研究也表明, 远程缺血预适应不仅可以降低新发梗死的发生率, 也可以促进脑梗死体积的缩小, 同时又不影响血压的变化; 而 NIHSS 评分的检测也表明其更有利于患者神经功能的恢复。

综上所述, 对缺血性脑血管病在常规药物治疗的基础上采用远程缺血预适应, 不仅可以减少新发梗死发生率、促进梗死体积的缩小, 也有利于神经功能的恢复, 更有利于改善患者病情。同时这种治疗值得在临床应用中推广。

【参考文献】

- [1] 冯美静, 杜继臣, 王培福. 远程缺血预适应对缺血性脑血管病患者治疗效果的影响分析 [J]. 陕西医学杂志, 2014, 43 (04): 401-402.
- [2] 鲁慧. 远程缺血预适应应用于缺血性脑血管病治疗中的效果观察 [J]. 世界最新医学信息文摘, 2016, 16 (36): 87-92.
- [3] 任善玲, 徐艳, 高永哲, 张磊. 缺血性脑血管病伴脑微出血的危险因素及其对认知功能的影响 [J]. 国际精神病学杂志, 2015, 42 (05): 39-43.
- [4] 曾敏, 龚细礼. 急性缺血性脑血管病血管内介入治疗进展 [J]. 现代医药卫生, 2017, 33 (02): 243-245.
- [5] 刘国政. 缺血性脑血管病的研究进展 [J]. 实用心脑血管病杂志, 2013, 21 (08): 5-6.

甲硫咪唑长期治疗甲亢的临床效果观察

朱晓燕

(德阳市旌阳区中医院 四川德阳 618000)

【摘要】目的: 对甲硫咪唑长期治疗甲亢患者的临床效果进行分析和探讨。**方法:** 我院选择 2015 年 6 月—2016 年 6 月接收的 52 例甲亢患者作为研究对象进行分析, 将所有患者随机平均分成两组, 实验组和对照组, 每组患者 26 例。其中, 对对照组采用甲硫咪唑进行治疗, 当患者症状好转之后即停止使用药物, 而在实验组中, 对患者长期服用甲硫咪唑, 在对患者治疗一年半到两年之后, 再对两组患者的临床症状以及治疗效果进行观察比较。**结果:** 实验组中患者治疗总有效率为 96%, 对照组中总有效率为 68%, 在治疗一年之后, 对两组患者的临床症状进行统计, 实验组中患者出现甲状腺肿大、眼球突出以及甲亢复发的概率要明显低于对照组, P 值 < 0.05 , 两组差异显著, 因而具有统计学意义。**结论:** 通过对甲亢患者长期服用甲硫咪唑药物进行治疗, 能够达到很好的治疗效果, 患者在治疗之后出现甲亢复发率低, 且能够有效控制好甲状腺肿大或眼球突出等不良症状, 因而是一种较好的治疗方式, 具有很高的临床应用价值。

【关键词】 甲硫咪唑; 长期治疗; 甲亢

【中图分类号】 R581

【文献标识码】 A

【文章编号】 1007-8231 (2018) 17-0190-02

甲亢是甲状腺功能亢进的简称, 主要是因为患者本身甲状腺功能失调或者由于外界因素的影响而导致甲状腺激素分泌异常, 进而导致甲状腺毒症的发生。甲亢患者通常表现为甲状腺肿大、眼球突出、体质量下降、以及食量增大等问题, 若不及时治疗, 会严重危害患者的身体健康。因而要想改善患者的生活质量, 就需要对甲亢的治疗方式进行研究, 在临床治疗中, 通常采用甲硫咪唑药物进行治疗, 使用该药物对患者不会产生不利的影响, 且治疗效果显著, 然而在给药过程中, 不同的治疗方式也会产生不同的治疗效果。本研究为了探究甲硫咪唑在甲亢患者中的临床治疗效果, 选择了 52 例患者作为研究对象, 其具体结果如下。

1. 资料和方法

1.1 资料

我院选择了 2015 年 6 月—2016 年 6 月接收的 52 例甲亢患者作为研究对象尽心分析, 将所有患者随机平均分成实验组和对照组, 每组 26 人。所有患者都符合相应的甲状腺疾病诊断标准^[1]。在所有患者中, 女性患者 22 例, 男性患者 30 例, 年龄在 22 ~ 49 岁之间, 平均年龄为 32 岁。排除标准: 将肝功能受损、粒细胞异常、白细胞减少、不能积极配合治疗、孕妇、存在明

显应激反应以及存在其他慢性消耗性疾病而影响药物使用效果的患者给予排除。对两组患者的一般资料进行分析统计, 没有发现显著差异, P 值 > 0.05 , 因而不具有统计学意义。

1.2 采用方法

对对照组患者采用甲硫咪唑药物进行治疗, 让患者按时口服药物, 同时依据患者的实际情况和病情的严重程度选择合适的药剂量进行治疗。对于病情较轻的患者, 让患者每次口服 10mg, 每天口服两次; 对于重症患者, 让患者每次口服 10 ~ 15mg, 每天口服 3 次。为患者持续给药直到病情得以控制, 当患者的临床症状改善后停止药物的使用^[2]。对实验组患者采用同样的方式进行治疗, 不同的是, 当患者病情好转之后需要去医院进行复查, 同时医生要依据患者的实际情况对药量进行调整, 让患者持续服用药物, 治疗时间在 1 年以上。

1.3 观察指标

患者在治疗满 1 年之后, 对两组患者的临床症状以及治疗效果进行观察比较, 疗效的判定标准: 对患者按月检查 TSH、FT4、FT3, 每两周检查患者的血常规、肝功能以及心律失常, 若患者脉率减缓, 临床症状没有任何好转, 甲状腺激素有所恢复